Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Mia Escarlett Soto Cordero				Sexo	F X	M
Fecha Nacimiento	10/12/2014	Edad actual	11 años	3 meses	País natal:	Chilena	
Domicilio actual:	Calle sargento Aldea 131 Rinconada				Teléfono	75302687	
Lengua materna	Castellano	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X				
Lengua de uso	Castellano	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X				
Escolaridad actual:	6º	Establecimiento	Liceo Mixto Básico Nº 1				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 09-03-2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Mical Cordero Cataldo	Nombre:
Relación con el/la estudiante: madre.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 09-03-2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Tiare Tapia Herra	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Del anterior Colegio presenta antecedente de DEA (matemáticas)

En el anterior Colegio perdieron su carpeta, por lo que no posee la documentación.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar)	
Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro: DEA

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: X normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? X SI ☐ NO	Peso: 2,520	Talla:

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

nació prematura de 8 meses debido a que el padre tuvo golpeó a la madre y comenzó el trabajo de parto.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Si	X No	Traumatismos	Si	X No	Encefalitis	Si	X No
Obesidad	Si	X No	Intoxicación	Si	X No	Meningitis	Si	X No
Fiebre alta	Si	X No	Enfermedad respiratoria	Si	X No	Otra(s)		
Convulsiones	Si	X No	Asma	Si	X No			
Hospitalizaciones	X Si	No	Especifique motivos y duración: la Hospitalización fue porque nacio Prematura 5 días					

Se realizaron controles periódicos de salud	X Si	No		Vacunas	X Si	No

Observaciones:

cuando era pequeño se quemo el pie debido a que metió el pie en los rayos de la bicicleta.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3 meses	Se sienta sólo/a: 5 meses	Camina sin apoyo: 11 meses
Primeras palabras: 6 meses	Primeras frases: 1 año	Se viste solo/a: 2 Años 6 meses

Controla esfinter vesical Diurno: 1,6 Ā Nocturno: 1,6 Ā	Controla esfinter anal Diurno: 1,6 Ā Nocturno: 1,6 Ā

Observaciones:

no presento dificultades sensorio motriz

En su actividad motora general se aprecia: X normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** X normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	X Si	No	Caídas frecuentes	Si	X No	Dominancia lateral	X Si	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	X Si	No	Prensión	X Si	No	Pinza	X Si	No
Ensarta	X Si	No	Dibuja	X Si	No	Escribe	X Si	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	X Si	No	Manipula y Explora objetos	X Si	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA L

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Demanda objetos y compañía	Sí	No	Comprende prohibiciones	Sí	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Sí	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	No

Observaciones:
Durante su niñez demostró un buen desarrollo motor.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:
No presenta problemas visuales o auditivos.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma
☒ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO

Observaciones: Por el lado materno, la madre y el tío presentaron problemas de lenguaje.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☒ natural ☐ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☐ desmesurada Depende de la situación

Observaciones:
a la estudiante se le dificulta relacionarse con personas nuevas.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al dia	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): ——

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 8 hrs.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☒ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☒ alegre ☒ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:
la estudiante demuestra un buen estado de salud.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Veronica Cataldo	Abuela	53	5to medio	Personal de Aseo.
2. Juan Cataldo	Bis Abuelo	74	3° básico	Jubilado
3. Luis Palacios	Padrastro	25	universidad	Paramedico.
4. Rical Cordero	madre	29	Universidad	Trabajo Independiente
5. Elizabeth Osses	Hermana	6	1° básico	Estudiante
6. Alexandra Palacios	Hermana	3	Jardín	Jardín
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):
Diabetes - Hipertensión - problemas al corazón - Problema a los riñones - asmaticos Por parte materna existen todos estos antecedentes de enfermedades.
Observaciones: madre señala que familia materna tienen bastantes problemas de salud.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar												
Edad de ingreso al sistema escolar	2			Asistió a jardín infantil				Sí X		No		
Nº de colegios en que ha estudiado	3			Modalidad de enseñanza Regular X Especial ☐ Técnica ☐:								
Motivo de los cambios: Estudiante que fue victima de Bullying por sus compañeros y posteriormente por su profesora.												
Ha repetido curso/s	Sí		No X	Curso(s)		Motivo:						
Situación actual												
Nivel/curso actual	6°		**Dificultad de aprendizaje**	Sí X	No	**Dificultad para participar**	Sí X	No	**Conducta disruptiva**	Sí	No X	
Asiste regularmente	Sí X	No	Asiste con agrado	Sí X	No	Apoyo familiar en tareas	Sí X	No	Amigos (as)	Sí X	No	
Actitud de la familia												
¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante? X satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos)												
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante? X apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra												
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante? X apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ..... Especifique el tipo de refuerzos o premios: X expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....												
¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante? X madre X padre ☐ hermanos/as X Otros familiares ☐ Otros profesionales												
¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante? X alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)												
¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje? X Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)												

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- El padre biologico no ve a la niña, por lo que no existe comunicación ni apego con Nia

- Nia presenta apego por su padrastro, debido a que estuvo presente durante su niñez.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA